EONU

이어온유 · AI 소통 솔루션

이어지는 진료,
세 사람의 안심.

EONU

일상의 이야기를 진료로,
진료의 계획을 일상으로.

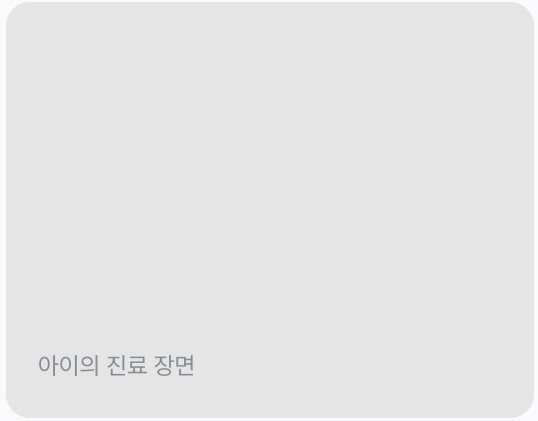
INVESTOR PRESENTATION · 2026.10

환자 · 보호자 · 의료진의 일상 장면



혼자 온 진료실에, 함께 와야 할 이야기

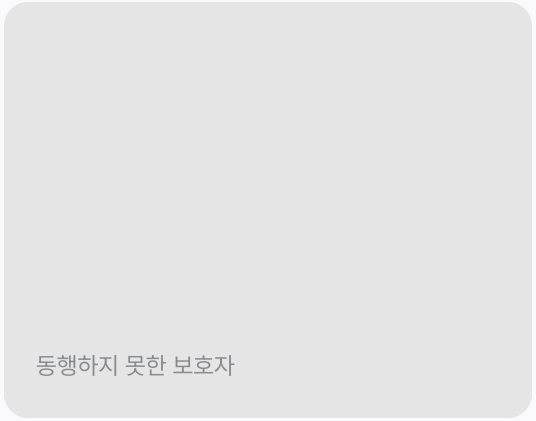
동행의 부재가 만드는 정보 전달의 공백에서 시작합니다.



01 · 환자

“언제부터 그랬나요?”

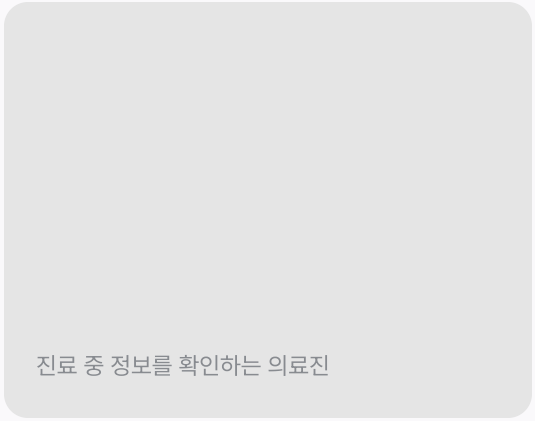
변화의 시점과 상태를
정확히 설명하기 어렵습니다.



02 · 보호자

“전할 말이 있는데”

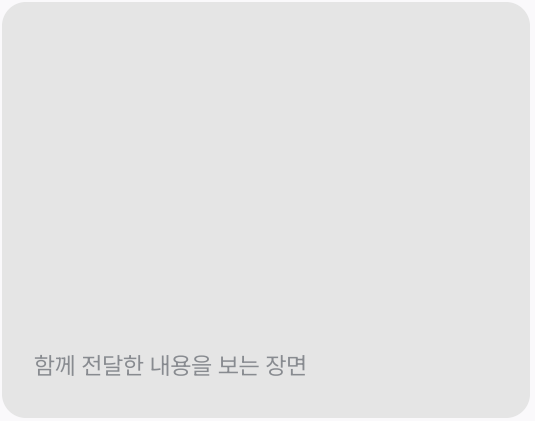
관찰한 내용은 있지만
지금 곁에 있을 수 없습니다.



03 · 의료진

“확인할 정보가 필요해요”

제한된 시간 안에
필요한 내용을 파악해야 합니다.



04 · EONU

“함께 남긴 내용을 확인”

환자·보호자가 선택한 정보를
의료진에게 연결합니다.

필요한 이야기도, 환자와 함께 진료실에 도착해야 합니다.

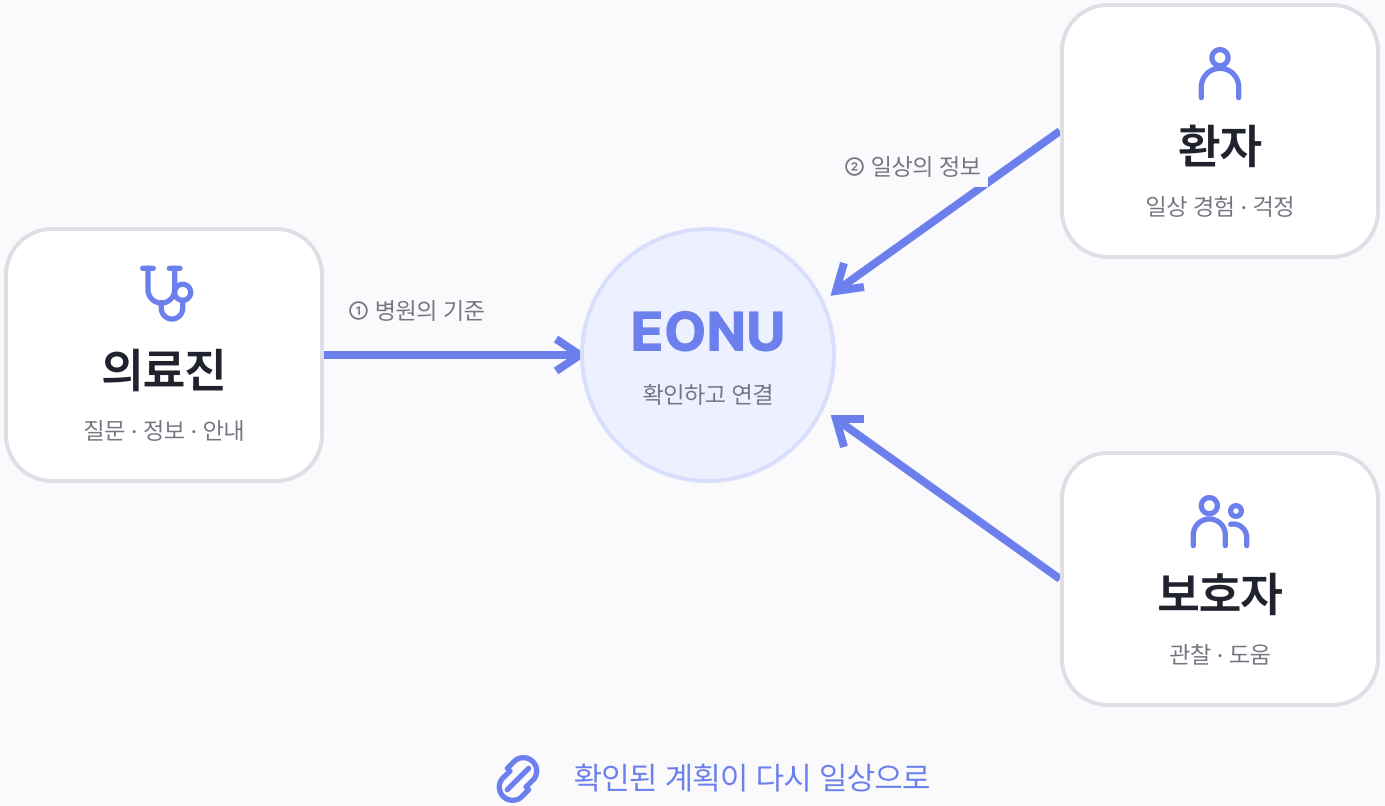
재구성한 설명용 사례

재구성한 설명용 사례. TV조선 2023.07.26 보도는 단독 내원 논란의 맥락 자료이며, 소통 공백의 빈도·증가를 입증하지 않습니다.

EONU

서로 다른 필요를 하나의 소통 흐름으로

환자의 경험, 보호자의 관찰, 의료진의 질문과 안내를 역할에 맞게 연결합니다.



환자 · 내 상황을 알아주길

일상 경험과 걱정을
필요한 내용으로 전달합니다.

보호자 · 전달하고 돕고 싶음

관찰을 공유하고
진료 후 도울 일을 확인합니다.

의료진 · 빠르게 파악하고 싶음

병원이 요청한 정보와
원문을 함께 확인합니다.

제품이 지향하는 가치와 연결 구조. 임상 효과·업무 시간 절감이 검증되었다는 의미는 아닙니다.

EONU

환자의 걱정이
병원의 상담 기회로

의료진이 지속해서 참여할 이유.
초기에는 수익 기여 가능성을 검증합니다.

진료 효율

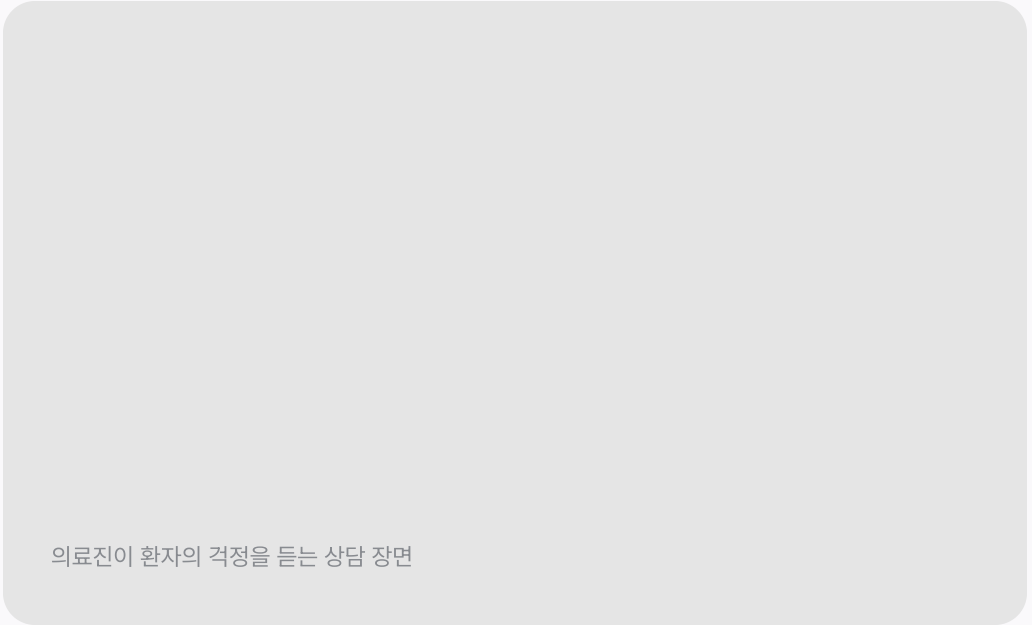
전체 업무 부담 측정

임상적 유용성

실제 활용 여부 확인

수익 기여

초기 검증 초점



의료진이 환자의 걱정을 듣는 상담 장면

01 / 미해결 걱정

일상에서 구체화

환자·보호자의 기록과 질문으로
관심과 궁금증을 확인합니다.

02 / 관련 정보

병원의 안내와 연결

병원이 설정한 서비스 정보를
환자가 확인합니다.

03 / 자발적 상담

환자가 상담을 선택

의료진이 필요성을 판단하고
지불할 업무 가치를 검증합니다.

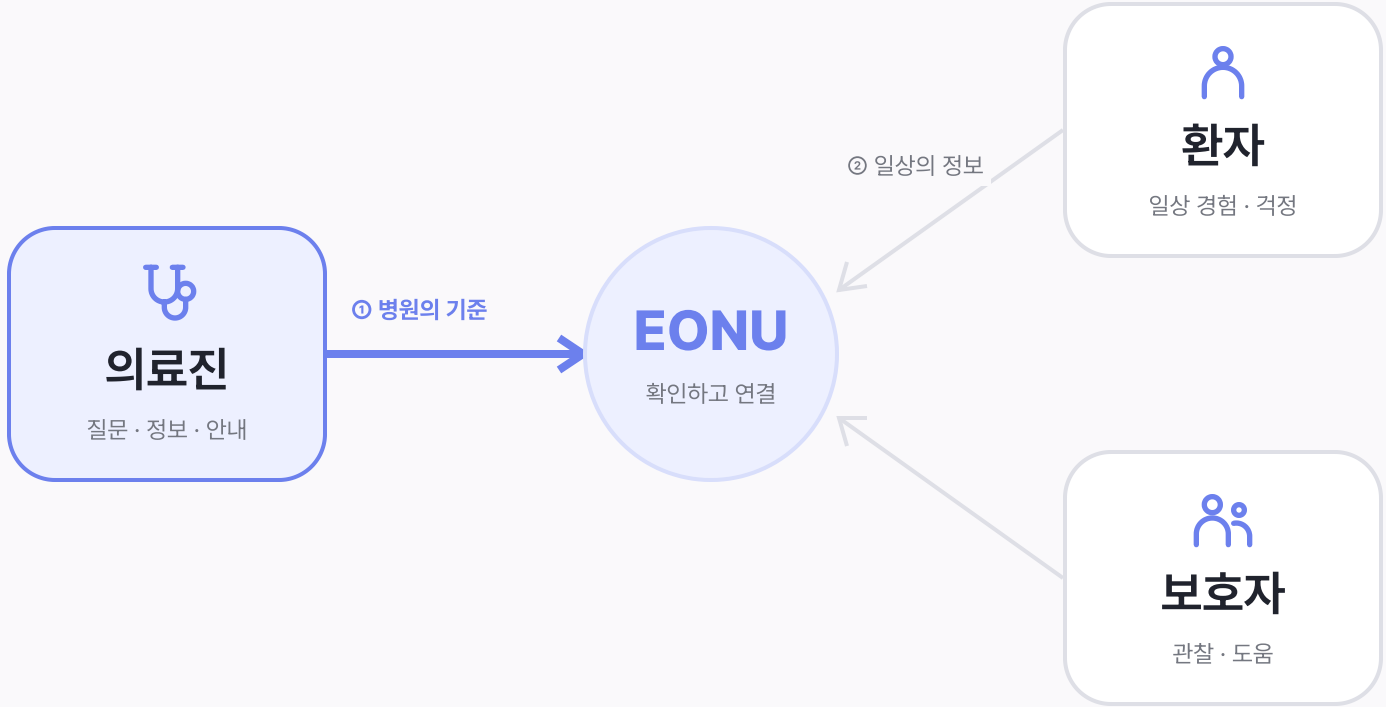
홈페이지·SNS·광고와 병행 · 측정: 정보 확인 → 상담 요청 → 병원의 유료 도입 의사

검증할 사업 가설. 개별 비급여의 필요성·상담 전환 성과는 미입증. 정보 제공·상담 연결 방식은 법적 검토 범위를 확인해야 합니다.

병원의 기준으로 시작하는 소통

의료진이 확인할 질문, 서비스 정보, 진료 후 안내를 먼저 설정합니다.

질문과 서비스 정보를 설정하는 의료진



의료진의 질문이
일상 기록의 기준이 됩니다.

병원 안내 QR → 환자·보호자 연결 화면에서 시작

설명용 제품 구조. 병원 안내 QR은 진입 방식이며, 이 자료에는 실제 접속용 QR을 넣지 않았습니다.

EONU

편하게 기록하고, 전달 전 직접 확인합니다

병원 설정 → 환자·보호자 기록 → 공유 범위 확인 → 의료진 확인

01 의료진 세팅

병원이 정하는 확인 기준

질문: 변화가 시작된 시점

질문: 불편했던 일상 장면

서비스 정보와 관리 안내

질문 · 관련 정보 · 진료 후 할 일

환자·보호자에게 안내

02 일상 기록

달력에서 할 일 확인

월	화	수	목	금	토	일
12	13	14	15	16	17	18

✓ 오늘의 관리 계획 확인

일기 · 음성 · 체크로 기록

환자 기록 보호자 관찰

AI가 전달 요약 초안 정리

03 공유 전 확인

원문과 요약을 함께 확인

원문 "저녁에 더 불편했어요."

요약: 저녁 불편감 보고

시작 시점: 미확인

이 항목 공유

공유 대상 담당 병원

당사자 확인 후 전달

04 의료진 확인

요청 항목별 전달 내용

요약 + 연결된 원문 확인

환자 / 보호자 작성 구분

미확인 항목은 추가 질문

확인 상태 구분 · 기존 EMR 옆 화면

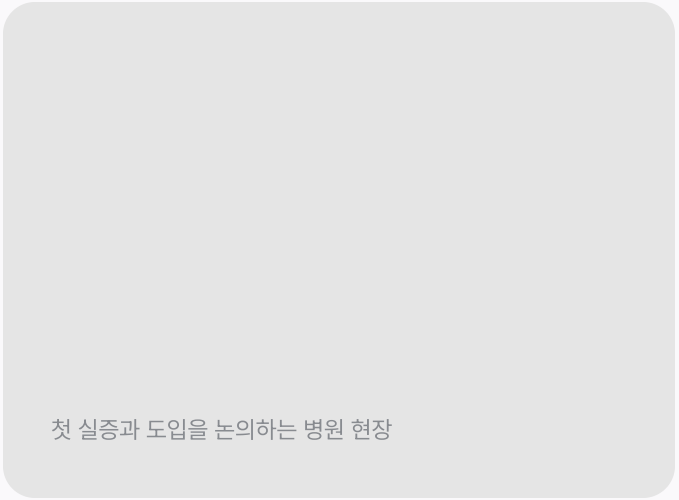
진료 후 안내 → 일상으로

원문 · 작성자 · 시점 · 확인 상태를 남기고, 공유 범위를 직접 조정합니다.

실제 서비스 캡처가 아닌 설명용 UI 도식·가상 데이터. 구현 완료나 안전성 검증, EMR 연동 완료를 의미하지 않습니다.

병원에서 시작하고, 공공 영역도 검증합니다

초기 B2B 라이선스에서 유료 도입을 검증한 뒤 확장합니다.



첫 실증과 도입을 논의하는 병원 현장

첫 고객은 일차의료기관

반복되는 소통 문제 × 도입 가치
× 실증 협조 가능성으로 선정

B2B 라이선스

기관 단위 반복 이용료 가설

먼저 검증할
핵심 매출 경로

B2B2C

환자·보호자의 추가 유료 가치
병원 도입 이후 별도 검증

B2G

소통 지원이 필요한 현장
구매기관·예산·조달 경로 확인

가상 사례 검토 → 제한 실증 → 유료 제안 → 계약

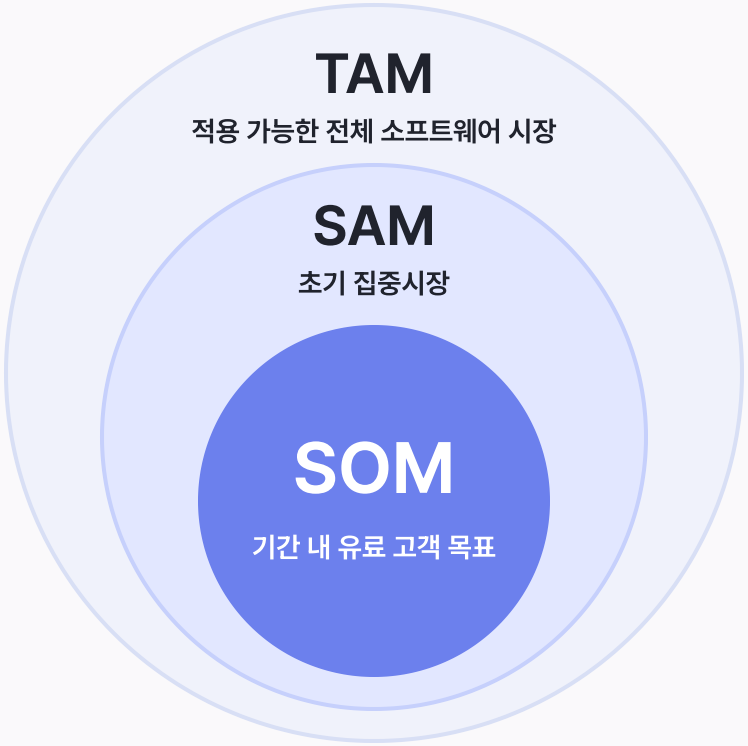
동의·공유 권한·의료진 확인 절차와 전체 업무 부담을 함께 점검

첫 병원군·가격·계약 상태 미확정. B2G는 공공 구매 계약을 의미하며, 연구지원금·민간 봉사활동과 구분합니다.

EONU

현재 판매할 상품으로 시장을 계산합니다

소프트웨어의 매출 상한과 일정 기간 내 실제 확보 목표를 구분합니다.



포함 관계를 나타낸 개념도 · 금액·비율에 비례하지 않음

B2B · 기관 라이선스

대상 기관 [ ]곳 × 연간 가격 [ ]원

초기 시장 상한과 실제 유료 고객 목표를 분리

B2B2C · 추가 유료 서비스

이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액

기관 계약에 포함된 요금과 중복 합산하지 않음

B2G · 별도 구매 계약

구매사업 [ ]건 × 계약 단가 [ ]원

동일 공급 계약·연구지원금·미래 기기 매출 제외

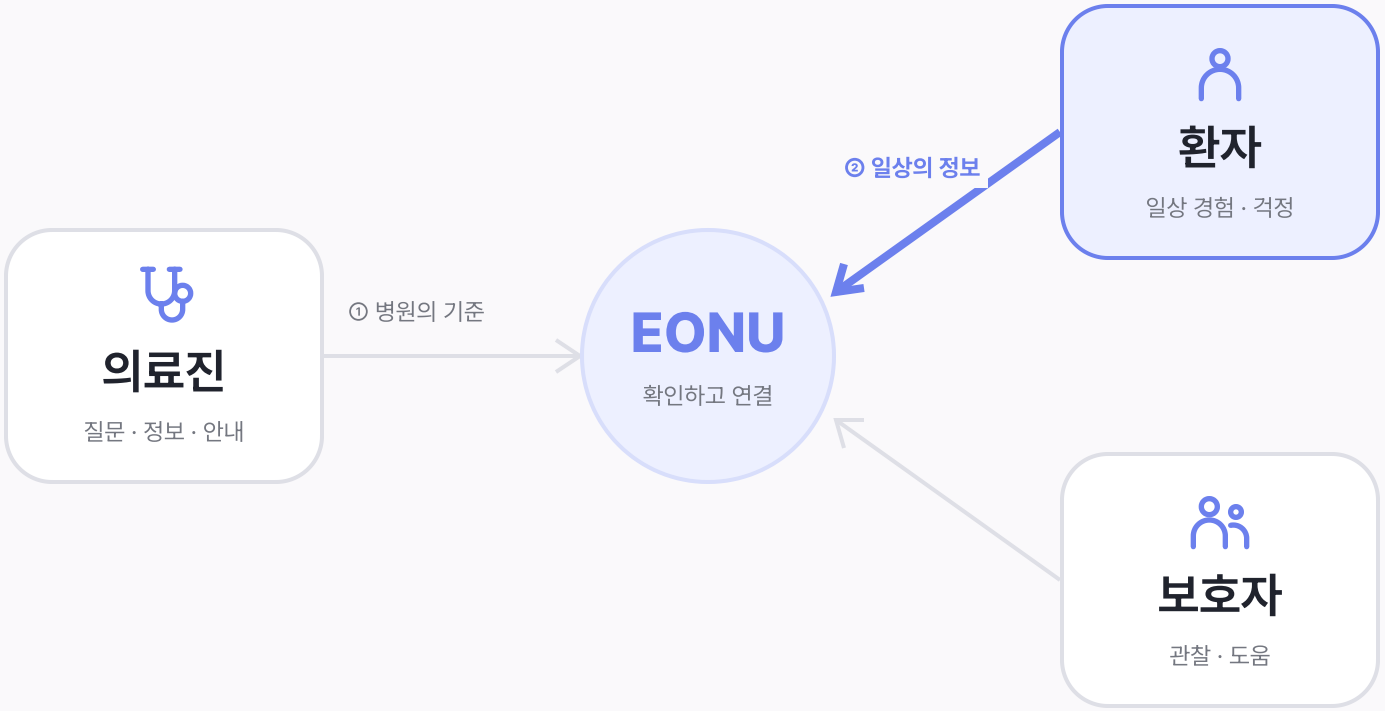
가격은 제공 원가·운영 비용과 업무 가치·지불 의사로 검증

원문의 시장 입력값은 미확정. 포함 관계를 나타낸 개념도이며 도형 면적은 시장 금액·비율에 비례하지 않습니다.

쌓이는 일상 정보를 진료에 활용하도록

병원 도입 검증 이후, 환자 정보의 임상적 유용성과 수집 부담을 확인합니다.

일상을 기록하는 환자와 가족 · 기기 활용 장면



정보의 의미와
입력 부담을 함께 검증합니다.

01 일상 기록의 활용·반복 사용

02 EMR·외부 앱 연동 검토

03 기기·바이오마커 추가 연구

확장 방향·연구 과제. EMR·외부 앱·기기 연동 및 디지털 바이오마커는 구현·임상 검증 완료를 의미하지 않습니다.

EONU

진척은 증빙으로, 다음 단계는 지표로

현장에서 실제로 쓰이는 질문·정보 구조·운영 경험을 축적합니다.

현장 인터뷰 · 피드백을 반영하는 제품 검토

다음 검증의 초점은 사용 · 부담 · 구매

01 의료진 확인율 · 정보 수정·누락

02 작성·확인·후속 업무의 전체 부담

03 반복 사용 · 유료 제안 · 계약

확인 항목	최신 MD 기재 내용	자료 상태
MVP	구현 범위·사용 가능 기능 [확인 필요]	미확정
전문의 피드백	정신과 전문의의 지속 피드백 언급	범위 확인
기관 접점	의료혁신 연구소 관련 접점 언급	상태 확인
봉사 프로젝트	청년 우울증·자선사업 참여 확정 기재	원문 기재
실증 · 유료 계약	기관 수·기간·계약 증빙 [확인 필요]	미확정
법적 검토	검토 범위·의견·완료일 [확인 필요]	미확정

축적 자산: 질문 · 템플릿 · 피드백 반영 · 운영 경험

2026.10.20 MD 기재 기준. 기관·전문의 관련 언급은 자문·협의 범위 확인 필요. 계약·실증 실적 또는 공식 제휴로 표시하지 않았습니다.

1억 원으로 첫 유료 모델을 검증합니다

직접 기획·개발하는 실행력에 임상 확인·보안·실증 운영 협력을 더합니다.



기획 → 개발 → 수정

의료·AI 이해를 바탕으로
현장 질문을 제품으로 구현하고
피드백을 직접 반영합니다.

1억 원

USE OF FUNDS · 배분 확정 전

제품 개발·개선	[ ]만 원
개인정보·보안 검토	[ ]만 원
실증 설계·운영	[ ]만 원
고객 확보·방문 데모	[ ]만 원
API·클라우드·운영	[ ]만 원

항목별 합계 = 10,000만 원
제공 원가와 고객 획득 비용은 분리 산정

자금이 만들 검증 결과

[ ]개월 — **집행 기간**
월별 소진 계획과 연결

[ ]곳 — **실증 기관**
활용·부담·반복 사용 확인

[ ]곳 — **유료 고객**
가격 수용성과 구매 검증

소개·접촉 → 방문 데모 → 파일럿 → 유료 제안
CAC = 획득 비용 ÷ 신규 유료 기관 수

1억 원은 MD의 사용계획 총액. 항목별 배분·집행 기간·실증 및 유료 고객 목표·CAC는 미확정이며 [ ]로 유지했습니다.

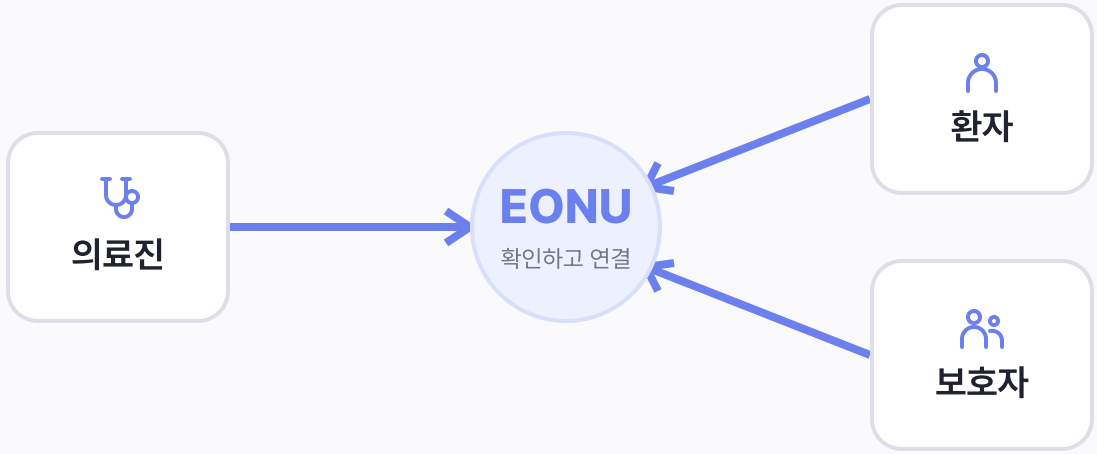
일상으로 돌아온 환자와 보호자의 장면

일상의 이야기를 진료로,
진료의 계획을 일상으로.

EONU

환자·보호자가 원하는 연결,
의료진도 지속할 이유.

첫 병원군과 함께,
현장에서 쓰이고 지불할 가치를 검증하겠습니다.



이어온유 · 연락처 [확인 후 입력]